ＰＳＬＳプロトコール

BANDO-MC 協議会
指示指導部会
Vre. 220708

Step 1 状況評価
① 通報者情報の確認
② 現場確認、安全確認
③ 傷病者数の確認

↓

Step 2 初期評価
A 意識と気道の評価
B 呼吸の評価
C 循環の評価
D 神経症状の評価

→ 内因性ロード＆ゴー

異常なし ↓ 異常あり

Step 3 判断
脳卒中の疑いがあるか否か？ シンシナティ病院前脳卒中スケール（CPSS）による評価、１つ以上陽性もしくは突然の激しい頭痛

→ No → 通常の重点観察へ

Yes ↓

Step 4 LVO 疑いの有無
ELVO スクリーンの実施
１項目以上の陽性かつ以下の条件を全て満たす傷病者であること（自宅生活者・24 時間以内の発症・血栓回収脳卒中センターに 60 分以内に搬送可能なこと）

→ No → 一次脳卒中センター（PSC）を選定

Yes ↓

Step 5 ファーストコール
血栓回収脳卒中センター（TSC）を選定
医療機関への情報提供（MIST）
発症時刻の確認・不整脈の有無

↓

Step 6 車内活動
車内収容時の対応
継続観察
KPSS による評価
セカンドコール（必要時）

Step 2 初期評価
A の異常 気道閉塞又は高度狭窄
JCS3 桁で気道確保が困難
B の異常
呼吸様式の異常（チェーンストークス、中枢性過換気、クスマウル呼吸など） 呼吸数 10 回/分未満、又は 30 回/分以上
C の異常
皮膚冷汗、湿潤、頻脈を伴う、または脈拍を触知しない
D の異常
JCSⅢ-300 で両瞳孔散大、JCSⅢ-200 で除皮質肢位、JCSⅡ桁またはⅢ桁で瞳孔異常を伴う、GCS8 以下で瞳孔異常を伴う

Step３判断 シンシナティ病院前脳卒中スケール（CPSS）

顔のゆがみ（歯を見せるように、あるいは笑ってもらう）
- ・正常 － 顔が左右対称
- ・異常 － 片側が他側のように動かない

上肢の挙上（閉眼させ、10 秒間上肢を挙上させる）
- ・正常 － 両側とも同様に挙上、あるいはまったく挙がらない
- ・異常 － 一側が挙がらない、他側と比較して挙がらない

構音障害（患者に話をさせる）
- ・正常 － 滞りなく正確に話せる
- ・異常 － 不明瞭な言葉、間違った言葉、まったく話さない

Step 4 LVO（脳主幹動脈閉塞）疑いの有無

ELVO スクリーン（Emergent Large Vessel Occlusion Screen）

・共同偏視
一方向のみを注視 あり→陽性

・失語
時計、眼鏡を見せて何かを訊ねる 答えられない→陽性

・半側空間無視
指４本を見せて本数を訊ねる 間違い→陽性

搬送ルールの条件について

自宅生活者であること・・・　施設入所者を指す。年齢や病前の生活自立度は問わない。施設入所者は元来基礎疾患を抱えているケースが多く、血栓回収治療を行ってもその後のADL・生活自立度を上げることが見込めないため。

24時間以内の発症　・・・　発症から24時間以内であれば血栓回収治療の効果が見込めるため。

血栓回収脳卒中センターに60分以内に搬送可能であること　・・・　血栓回収治療が可能な病院が遠い場合には近隣の一次脳卒中センター（PSC）に搬送しt-PAでの治療を行い、血栓回収治療可能な病院に転送する。
（病院選定については現場との距離や搬送予想時間等から考慮すること）